Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Central de Agilização Processual de Caruaru

AV JOSÉ FLORÊNCIO FILHO, S/N, MAURÍCIO DE NASSAU, CARUARU - PE - CEP: 55014-837 - F:(81) 37257687

Processo nº 0000483-10.2016.8.17.2980

ESPÓLIO: HOSANA PAULA DA SILVA

ESPÓLIO: ESTADO DE PERNAMBUCO, PGE - PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL

SENTENÇA

-

O Sr. GABRIEL FERNANDES DA SILVA, já qualificada nos autos, ajuizou a presente "ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência" contra o ESTADO DE PERNAMBUCO, igualmente identificado, alegando que necessita de tratamento medicamentoso de **HIDROLISADO DE PROTEÍNAS – MUINUTRI SOJA, PEG 4000, RESPIRIDONA, NEULESPTIL, na forma e quantidade prescrita pelo médico, no prazo de 48 h (quarenta e oito horas)**, bem como proceda a realização do exame de RESSONÂNCIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, SEM CONTRASTE E UM ECOCARDIOGRAMA, conforme requisitado pelo médico, com a devida regularidade. Sustenta que não recebe a medicação, em que pese tenha solicitado. A título de tutela provisória de urgência a parte autora requereu que o Demandado seja compelido a fornecer o medicamento.

Com a inicial vieram documentos, em especial os laudos médicos.

O requerido apresentou contestação, pugnando pela ilegitimidade passiva do ente, bem como da ausência de obrigação de fornecer o referido medicamento.

A demandante requereu o julgamento antecipado da lide.

Este é o relatório.

Tudo bem visto e ponderado, **DECIDO**.

Cumpre esclarecer que o feito comporta julgamento abreviado, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo, pois, totalmente desnecessária a dilação probatória para a oferta da prestação jurisdicional, uma vez que os documentos coligidos aos autos se afiguram suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia instaurada.

Na lição de Marcelo José Magalhães Bonicio[1] (file:///C:/Users/acsarr/Desktop/Desktop/Senten%C3%A7as/Junho%20-%202021/0000193-38.2013.8.17.1480%20-%20Helena%20Xavier%20x%20Estado%20de%20Pernambuco%20-%20Fornecimento%20de%20Medicamento.rtf#_ftn1), "a fase instrutória do processo costuma ser mais longa do que o necessário, servindo muito mais aos propósitos protelatórios das partes do que ao descobrimento da verdade. A excessiva complacência dos juízes, temerosos em indeferir o requerimento de produção de provas, contribui sensivelmente para agravar esta situação (...). Exatamente neste ponto encontra-se a primeira possibilidade de utilização do princípio da proporcionalidade no campo das provas".

Desta forma, perfeitamente cabível que se julgue antecipadamente o mérito, sem olvidar que, nos termos do Código de Processo Civil, compete ao magistrado velar pela rápida solução do litígio, privilegiando a efetividade do processo, quando prescindível a instrução processual (cf. José Roberto dos Santos Bedaque, Efetividade do Processo e Técnica Processual, 2a ed., Malheiros, p. 3234), e atendendo a garantia constitucional de razoável duração do processo mencionada no artigo 5°, inciso LXXVIII, da CRFB.

Por oportuno, cabe esclarecer que "Não é necessário o anúncio prévio do julgamento do pedido nas situações do art. 355 do CPC" (Enunciado n° 27 da I Jornada de Direito Processual Civil realizado STJ/CJF).

As partes são legítimas e estão bem representadas, além de que o interesse de agir é evidente. Os pressupostos processuais estão presentes e não há questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação.

Superada essa questão, passo a enfrentar o mérito.

O cerne da presente demanda está em verificar se o ESTADO DE PERNAMBUCO deve ser compelido a fornecer ao demandante os medicamentos **HIDROLISADO DE PROTEÍNAS – MUINUTRI SOJA, PEG 4000, RESPIRIDONA, NEULESPTIL, na forma e quantidade prescrita pelo médico, no prazo de 48 h (quarenta e oito horas)**, bem como proceda a realização do exame de RESSONÂNCIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, SEM CONTRASTE E UM ECOCARDIOGRAMA, conforme requisitado pelo médico

Sem maiores delongas, registro, desde logo, que o pedido formulado na exordial deve ser julgado **procedente**.

A CRFB, em seu art. 6º, estabelece que:

"São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição".

Por sua vez, o art. 196 da Carta Magna define que:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Conforme se depreende dos preceitos constitucionais suso transcritos, compete ao Poder Público garantir e assegurar o direito à saúde, que é indissociável do direito à vida, prerrogativa constitucional com caráter de direito fundamental, que não pode ser preterido por questões burocráticas, políticas, econômicas ou orçamentárias.

Neste passo, já afirmou o Ministro Marco Aurélio que "o Estado deve assumir as funções que lhe são próprias, sendo certo, ainda, que problemas orçamentários não podem obstaculizar o implemento do que previsto constitucionalmente"[2] (file:///C:/Users/acsarr/Desktop/Desktop/Senten%C3%A7as/Junho%20-%202021/0000193-38.2013.8.17.1480%20-%20Helena%20Xavier%20x%20Estado%20de%20Pernambuco%20-%20Fornecimento%20de%20Medicamento.rtf#_ftn2).

No expressivo dizer de José Afonso da Silva, "o sistema único de saúde, integrado de uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, constitui o meio pelo qual o Poder Público cumpre seu dever na relação jurídica de saúde que tem no pólo ativo qualquer pessoa e a comunidade, já que o direito à promoção e à proteção da saúde é também um direito coletivo. O sistema único de saúde implica ações e serviços federais, estaduais, distritais (DF) e municipais, regendo-se pelos princípios da descentralização, com direção única em cada esfera de governo, do atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, e da participação da comunidade, que confirma seu caráter de direito social pessoal, de um lado, e de direito social coletivo, de outro"[3] (file:///C:/Users/acsarr/Desktop/Desktop/Senten%C3%A7as/Junho%20-%202021/0000193-38.2013.8.17.1480%20-%20Helena%20Xavier%20x%20Estado%20de%20Pernambuco%20-%20Fornecimento%20de%20Medicamento.rtf#_ftn3).

Nessa esteira de raciocínio, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal: "O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconseqüente. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado"[4] (file:///C:/Users/acsarr/Desktop/Desktop/Senten%C3%A7as/Junho%20-%202021/0000193-38.2013.8.17.1480%20-%20Helena%20Xavier%20x%20Estado%20de%20Pernambuco%20-%20Fornecimento%20de%20Medicamento.rtf#_ftn4).

Conclui-se, pois, que a garantia constitucional e/ou direito à saúde e os meios necessários para a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana não significam tão somente um “sonho” do legislador constituinte embebido em devaneio altruísta.

A moderna hermenêutica constitucional aponta para a máxima eficácia das normas, mesmo em se tratando de normas programáticas, sendo que no caso depara-se com normas imediatamente preceptivas, dado o grau imediato de comando e eficácia.

Assim, seja com base nos preceptivos constitucionais invocados, de eficácia não programática, mas auto-executáveis, seja com base na legislação infraconstitucional, o direito invocado está garantido na *Lex Mater*, e deve ser efetivado mediante a obrigação dos Municípios e do Estado em arcar com despesas referentes ao fornecimento de medicamentos e insumos, devidamente prescritos, aos cidadãos sujeitos a tratamento médico específico e, por conseguinte, garantirem o direito a vida.

Nesse passo, o fato de alguém necessitar de tratamento inadiável, aliado ao impostergável dever do Estado de assegurar a todos os cidadãos, especialmente os mais carentes, o direito à saúde, justifica a imposição ao ente público da obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso, fornecendo-lhes, sobretudo em casos como o figurado em tela, os meios necessários para garantir-lhes melhor qualidade de vida, diminuindo os sofrimentos de que padecem.

No caso *sub examine*, conforme os laudos médicos de fls. 13-16, há a necessidade de fornecimento dos referidos medicamentos à demandante.

Desta forma, o reconhecimento da procedência dos pedidos é medida que se impõe.

Finalmente, registro que, apesar de incontestável o dever de o ente público fornecer o insumo pleiteado, essa obrigação **não pode ser perpétua**. Em geral, a enfermidade acometida aos pacientes é tratada com medicamentos e a evolução das drogas e procedimentos médicos evasivos ou não, podem no futuro próximo culminar com a cura, isto é, o pleno restabelecimento daquele. Da mesma forma, em se tratamento de fornecimento de medicamento, pode acontecer de não ser mais necessário a partir de determinado momento da vida da paciente.

Por isso, permite-se ao requerido, por meio do órgão competente, **analisar periodicamente** a eventual melhora e/ou total restabelecimento do impetrante e/ou desnecessidade de fornecimento do bem de vida pleiteado, que **perdurará até que haja expressa recomendação médica em sentido contrário**, devendo a parte autora, nos termos do Enunciado nº 2, da 1ª Jornada de Saúde Pública do Conselho Nacional de Justiça[5] (file:///C:/Users/acsarr/Desktop/Desktop/Senten%C3%A7as/Junho%20-%202021/0000193-38.2013.8.17.1480%20-%20Helena%20Xavier%20x%20Estado%20de%20Pernambuco%20-%20Fornecimento%20de%20Medicamento.rtf#_ftn5), **apresentar ao órgão competente indicado pelo ente público demandado receita médica <u>a cada três meses</u>**, para continuidade do fornecimento do produto em testilha.

Consigno, por fim, terem sido enfrentados todos os argumentos trazidos pelas partes capazes de influenciar na convicção do julgador, consoante art. 489, §1º, IV, do CPC. Aliás, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça[6] (file:///C:/Users/acsarr/Desktop/Desktop/Senten%C3%A7as/Junho%20-%202021/0000193-38.2013.8.17.1480%20-%20Helena%20Xavier%20x%20Estado%20de%20Pernambuco%20-%20Fornecimento%20de%20Medicamento.rtf#_ftn6) decidiu que "[...]. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. [...]".

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da demanda para **JULGAR PROCEDENTE** o pedido formulado na petição inicial para **CONDENAR** o ESTADO DE PERNAMBUCO a fornecer ao demandante: HIDROLISADO DE PROTEÍNAS – MUINUTRI SOJA, PEG 4000,

RESPIRIDONA, NEULESPTIL, na forma e quantidade prescrita pelo médico, bem como proceda a realização, caso não tenha ocorrido, do exame de RESSONÂNCIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, SEM CONTRASTE E UM ECOCARDIOGRAMA, conforme requisitado pelo médico, devendo a demandante **apresentar ao órgão competente indicado pelo ente público demandado receita médica a cada três meses**, para continuidade do fornecimento do produto em testilha.

Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte autora, que incidirão nos percentuais mínimos estipulados em cada uma das faixas de valores dos incisos I a V do § 3º do art. 85 do CPC. Não há falar em condenação do réu em custas processuais diante da isenção que goza a Fazenda Pública Municipal.

Na forma do art. 496 do CPC, Súmula n° 490[7] (file:///C:/Users/acsarr/Desktop/Desktop/Senten%C3%A7as/Junho%20-%202021/0000193-38.2013.8.17.1480%20-%20Helena%20Xavier%20x%20Estado%20de%20Pernambuco%20-%20Fornecimento%20de%20Medicamento.rtf#_ftn7) do STJ e REsp 1101727/PR[8] (file:///C:/Users/acsarr/Desktop/Desktop/Senten%C3%A7as/Junho%20-%202021/0000193-38.2013.8.17.1480%20-%20Helena%20Xavier%20x%20Estado%20de%20Pernambuco%20-%20Fornecimento%20de%20Medicamento.rtf#_ftn8) (recurso repetitivo), tratando-se de sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, aguarde-se prazo para interposição de recurso voluntário e remetam-se os autos em seguida ao Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado. Após, arquive-se.

Em sendo interposto recurso de **APELAÇÃO**, por não haver mais o juízo de prelibação nesta Instância (art. 1.010 do Código de Processo Civil), sem necessidade de nova conclusão, nos termos do art. 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil, **INTIME-SE** o(a) apelado(a) para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997 do CPC), **INTIME-SE** a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do CPC.

Caso sejam apresentadas contrarrazões, em sendo suscitadas preliminares, **INTIME-SE** o apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.009, § 2º, do Código de Processo Civil, manifeste-se acerca das referidas questões.

Após o prazo, com ou sem resposta, *ex vi* do disposto no § 3º do art. 1.010 do CPC, **REMETAM-SE** os autos ao E. Tribunal de Justiça de Pernambuco, independentemente do juízo de admissibilidade.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado. Após, arquive-se.

Caruaru/PE, 07 de março de 2022.

Augusto Cézar de Sousa Arruda
Juiz de Direito Substituto

---

[1] (file:///C:/Users/acsarr/Desktop/Desktop/Senten%C3%A7as/Junho%20-%202021/0000193-38.2013.8.17.1480%20-%20Helena%20Xavier%20x%20Estado%20de%20Pernambuco%20-%20Fornecimento%20de%20Medicamento.rtf#_ftnref1) Proporcionalidade e processo: a garantia constitucional da proporcionalidade, a legitimação do processo civil e o controle das decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 2006, p. 80

[2] (file:///C:/Users/acsarr/Desktop/Desktop/Senten%C3%A7as/Junho%20-%202021/0000193-38.2013.8.17.1480%20-%20Helena%20Xavier%20x%20Estado%20de%20Pernambuco%20-%20Fornecimento%20de%20Medicamento.rtf#_ftnref2) Voto condutor nos autos do RE 195.192-3/RS - Segunda Turma do STF - julgado em 22/02/00.

[3] (file:///C:/Users/acsarr/Desktop/Desktop/Senten%C3%A7as/Junho%20-%202021/0000193-38.2013.8.17.1480%20-%20Helena%20Xavier%20x%20Estado%20de%20Pernambuco%20-%20Fornecimento%20de%20Medicamento.rtf#_ftnref3) Curso de Direito Constitucional Positivo, 11. ed. - São Paulo: Malheiros Editores, 1996, p. 762.

[4] (file:///C:/Users/acsarr/Desktop/Desktop/Senten%C3%A7as/Junho%20-%202021/0000193-38.2013.8.17.1480%20-%20Helena%20Xavier%20x%20Estado%20de%20Pernambuco%20-%20Fornecimento%20de%20Medicamento.rtf#_ftnref4) STF, 2ª Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 271.286/RS, Relator Ministro Celso de Mello, j. 12.09.2000, DJ 24.11.2000, p. 101.

[5] (file:///C:/Users/acsarr/Desktop/Desktop/Senten%C3%A7as/Junho%20-%202021/0000193-38.2013.8.17.1480%20-%20Helena%20Xavier%20x%20Estado%20de%20Pernambuco%20-%20Fornecimento%20de%20Medicamento.rtf#_ftnref5) ENUNCIADO Nº 2: Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida.

[6] (file:///C:/Users/acsarr/Desktop/Desktop/Senten%C3%A7as/Junho%20-%202021/0000193-38.2013.8.17.1480%20-%20Helena%20Xavier%20x%20Estado%20de%20Pernambuco%20-%20Fornecimento%20de%20Medicamento.rtf#_ftnref6) EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

[7] (file:///C:/Users/acsarr/Desktop/Desktop/Senten%C3%A7as/Junho%20-%202021/0000193-38.2013.8.17.1480%20-%20Helena%20Xavier%20x%20Estado%20de%20Pernambuco%20-%20Fornecimento%20de%20Medicamento.rtf#_ftnref7) "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas"

[8] (file:///C:/Users/acsarr/Desktop/Desktop/Senten%C3%A7as/Junho%20-%202021/0000193-38.2013.8.17.1480%20-%20Helena%20Xavier%20x%20Estado%20de%20Pernambuco%20-%20Fornecimento%20de%20Medicamento.rtf#_ftnref8) "RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CABIMENTO. 1. É obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (Código de Processo Civil, artigo 475, parágrafo 2º). 2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil." (STJ, REsp 1101727/PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2009, DJe 03/12/2009)

Assinado eletronicamente por: AUGUSTO CEZAR DE SOUSA ARRUDA
07/03/2022 15:37:27
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 100414220

22030715372722500000098233973

IMPRIMIR GERAR PDF